Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

SORBONNE UNIVERSITÉ
2025 - 2026

SHS – Droit et éthique

Fiche de cours n°1

Introduction au droit de la santé

ACTUALISATION

PLAN

I. Introduction

II. Les droits fondamentaux des personnes

III. Les droits des usagers du système de santé

IV. Responsabilité des professionnels de santé

V. Conclusion

Légendes

Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Introduction	**Droit**

Définition	• Droit : un domaine extrêmement étendu
	• Droit = **l'ensemble des règles** qui permettent aux citoyens de vivre ensemble et qui **organisent la vie en société**
	  ○ Les textes de droit **régissent** toutes nos activités
	• Définition de **Boris Stark**, Professeur de droit civil :
	  ○ « L'ensemble des **règles de conduite** qui **gouvernent** les rapports entre les hommes et dont le respect est assuré par **l'autorité publique** »
	  ○ L'autorité publique est là pour faire respecter le droit
	• Le Droit encadre le **pouvoir de l'État**, organise les relations entre les institutions et entre les citoyens
	• Le Droit est **omniprésent** dans notre quotidien

I. Introduction	**Droit de la santé**	

Définition	• Droit de la santé = ensemble des **règles applicables** aux activités dont l'objet est d'améliorer, restaurer, protéger **la santé des personnes**
	  ○ Focus sur la santé
	  ○ Questions relatives au système de santé	

	4 domaines	• **Réglementations** et **encadrements** des activités médicales et paramédicales :
		  ○ Prévention, activités de soins, etc.
		  ○ Par exemple, les statuts des cadres de la fonction publique hospitalière
		• Réglementations en matière de **santé publique**
		  ○ Promotion de la santé, prévention et protection de la santé des populations, sécurité sanitaire et gestion des risques sanitaires
		  ▪ Ex : Campagne de vaccination
		• Organisation des activités des **professionnels** intervenant dans le domaine de la santé
		• Organisation des services publics et privés de santé
		  ○ Sécurité sociale
		  ○ Hôpitaux privés et publics

Droit de la santé	• Le droit de la santé **n'est pas une branche du droit** comme le sont le droit civil et le droit administratif
	  ○ Il est **polymorphe** et relève de plusieurs branches du droit comme le **droit privé** et le **droit public**
	  ○ Il englobe aussi d'autres **types de droit** (tableau suivant)	

Encadrement	**Règles de Droit privé**	• **Étudie la responsabilité civile ou pénale** des professionnels de santé ou des établissements de santé privés en cas de faute • Ce sont des règles qui régissent les rapports entre les individus et les institutions
	Règles de Droit public	• Étudie la **responsabilité administrative** des établissements de santé du secteur public ou de l'État en cas de faute

I. Introduction	Les différents types de droits dans le droit de la santé	
Définitions	• Le droit de la santé englobe aussi plusieurs **sous-ensembles** du droit :	
	Droit médical (ne signifie pas droit de la santé)	• **Le droit médical :** Ensemble des normes juridiques qui régissent et encadrent les droits, les obligations et les activités des **professionnels de santé** ○ Très accès sur l'activité médicale
	Bioéthique	• **La bioéthique :** ○ « L'ensemble de recherches, de discours et de pratiques, généralement pluridisciplinaires, ayant pour objet de **clarifier ou de résoudre des questions** à portée éthique suscitées par **l'avancement et l'application des technosciences biomédicales** » ▪ Ex : Questions autour de la Procréation Médicalement Assistée (PMA) ▪ Implique des chercheurs en sociologie, en droit…
	Déontologie des professionnels de santé	• **Déontologie** = « Science des devoirs » • Ensemble des **règles établies par la profession** régissant leur exercice professionnel ○ = Code de déontologie, ont une **valeur légale** ○ On retrouve ce code chez les médecins, les infirmiers, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens, les sage-femmes
	Droit hospitalier	• **Le droit hospitalier :** règles de droit applicables au sein des établissements de santé publics et privés ○ Les établissements privés et publics n'ont pas les mêmes règles
	Droit pharmaceutique	• **Le droit pharmaceutique :** ensemble des normes juridiques qui régissent et encadrent les professions et activités pharmaceutiques, le développement, la production et l'usage des **produits de santé**
	Droit de la sécurité sociale	• **Le droit de la sécurité sociale :** l'ensemble des règles juridiques qui concernent la sécurité sociale ○ Il existe un code de la Sécurité Sociale
Les sources du droit de la santé	• Le droit de la santé a plusieurs **sources :** ○ Les sources spécifiques et non spécifiques ▪ Les sources non spécifiques ne concernent pas uniquement la santé	

I. Introduction	Sources non spécifiques du droit de la santé
Sources internationales mondiales	• Sources internationales reconnaissant le droit à la santé : ○ 1946 : Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) ▪ Définit la santé comme « un état complet de **bien-être physique, mental et social** et ne consiste pas seulement en une **absence de maladie ou d'infirmité »** – Pas seulement ne pas avoir de pathologie ○ Organisation des Nations Unies (ONU) avec : ▪ **1948** : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ▪ **1976** : Pacte international relatif aux droits sociaux, économiques et culturels
Sources internationale européennes	• Sources issues du droit européens : ○ 1950-1953 : Convention Européenne des Droits de l'Homme ▪ Droit à la vie ▪ Interdiction des traitements inhumains et dégradants ▪ Respect de la vie privée ▪ Protection de la santé ○ **1997-1999** : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine dite **convention d'Oviedo**
Droit national (droit interne)	• Les sources non spécifiques proviennent aussi du **droit national français**, dit **droit interne :**
	Constitution de 1958 • Préambule plus ancien de la **Constitution de 1946** garantissait déjà : ○ Pour tous, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ▪ Notamment à **l'enfant**, à la **mère** et aux **vieux travailleurs** • La protection de la santé est un Droit de valeur constitutionnelle
	Codes de lois — **Code Civil** • **Code civil** : est né sous Napoléon • Est un **support du droit privé** qui institue : ○ Le **respect du corps humain** (art. 16 et suivants) ○ La protection juridique des majeurs : ▪ Les mises sous tutelle, curatelle, sauvegarde de justice, mandat de protection future (art. 414 et suivants) ~~- Les médecins sont sollicités pour ces mesures~~ ○ Le **droit de la responsabilité** : droit des contrats et des obligations ▪ Ex : responsabilité d'une entreprise lorsqu'elle fabrique un médicament ou cause un accident du travail ▪ Ex : responsabilité d'un médecin lorsqu'il soigne un patient
	Codes de lois — **Code Pénal** • **Code pénal** : rassemble des **infractions** et des peines applicables, concerne les **actes sanctionnables** pour la bonne vie en société • Infractions dans le domaine de la santé : ○ Violation du secret professionnel ○ Faux certificats médicaux ○ Atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ▪ Ex : problème lors d'une opération chirurgicale ○ Omission de porter secours ▪ D'autant plus lorsque l'on est un professionnel de la santé ○ Exercice illégal de la médecine ▪ Sans diplôme et reconnaissance légale

I. Introduction	Sources spécifiques
• Certaines sources du droit sont **spécialement dédiées** à la santé : ne s'appliquent qu'à la pratique médicale, paramédicale et des professionnels de santé	
Code de la Santé Publique (1953)	• 1953 : Le **code de la Santé publique** = ne parle que de la pratique médicale et régule : ○ Protection générale de la santé ○ Santé de la famille, de la mère et de l'enfant ▪ Populations plus fragiles ○ Lutte contre les maladies et dépendances ○ Professions de santé ○ Produits de santé ▪ Production et usage, responsabilité en cas de difficultés et d'accidents ○ Établissements et services de santé • Comprend des sanctions pénales
Codes de déontologie Professionnels de santé : Source de droit pour le personnel de santé	• **Le code de déontologie : la profession s'organise en ordre professionnel et promeut de bonnes pratiques obligatoires** ○ Est dans la section réglementaire du code de la Santé publique ○ Fais acte de loi et peut être utilisé en procès : sont opposables au praticien ▪ Concerne les médecins, infirmiers, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, sage-femme
Jurisprudence	• **La jurisprudence** correspond aux réglementations édictées par les procès passés ○ La justice doit toujours être la même d'un procès à l'autre ○ La jurisprudence a fait évoluer un certain nombre de pratiques médicales ○ Certaines ont ensuite fait acte de loi comme les arrêts du **conseil d'Etat** et de **la Cour de cassation**

II. Les droits fondamentaux des personnes : Emergence des droits des patients	**L'évolution historique des droits des patients 1/2**	
Focus sur le droit des patients		• Droit des patients : Focus de ce cours sur **mise en jeu des professionnels** ○ Droit des patients s'est **construit progressivement** au fil des jurisprudences et des lois ○ Plusieurs arrêts de jurisprudence comme l'arrêt Mercier et l'arrêt Teyssier, mais aussi la Constitution et la Déclaration Universelle des Droits de l'homme sont antérieurs au code de Santé publique ▪ Ils sont les premiers jalons du droit des patients ○ La problématique de **protéger les données** des personnes émergent pour la première fois dans les années **1970** ○ L'évolution des lois montrent **l'évolution de la société :** le droit médical est donc **mouvant** ▪ Les 3 lois de la bioéthique de 1994 en sont en exemple et montre l'évolution du droit selon les nouvelles biotechnologies – Révision de ces lois en 2004 puis en 2021 ○ La **principale loi** à retenir : loi du 4 mars **2002** « **Kouchner** »
1936	**Arrêt Mercier (Cour de Cassation : Les arrêts portent le nom de la famille plaignante du cas)**	• **Contexte de l'arrêt** : Radiodermite développée une patiente venue pour une radiothérapie de la face • **1936 Arrêt Mercier de la Cour de cassation**, en chambre civile : ○ Légalise l'existence d'un **contrat** entre le malade et le médecin ▪ Un contrat est un engagement réciproque ○ Obligation de soins découlant de ce **contrat médical** et mise à la charge du médecin est une **obligation de moyens** ▪ Obligation de moyens : on doit **tout faire** pour réussir mais on peut échouer. Cela **diffère d'une obligation de résultat**. ○ Le médecin ne pouvant s'engager à guérir, s'engage à donner des soins **consciencieux,** attentifs et conformes aux données acquises de la **science** ▪ Vise à éviter le charlatanisme ○ Fonde la responsabilité du médecin
1942	**Arrêt Teyssier (Cour Cassation)**	• **1942 Arrêt Teyssier de la Cour de cassation :** ○ Acter l'obligation du recueil du **consentement** du malade avant des examens ou un traitement ▪ Obligation dans le **respect de la personne humaine** ▪ Le cas contraire : une **atteinte grave** aux droits du malade, engage la responsabilité du médecin ~~– Cet arrêt concerne une patiente qui aurait souhaité dire non à de la chimiothérapie et qui a eu de graves séquelles~~ ▪ Le droit au consentement va donner par la suite **l'obligation d'informer** le patient
1946	**Préambule de la Constitution de la IVème République**	• **1946 Préambule de la constitution de la IVème République :** ○ La Nation garantit à tous la **protection** de la **santé**, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ○ Notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs
1948	**Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (Nations Unies)**	• **1948 Déclaration universelle des Droits de l'Homme** de l'ONU ○ Toute personne a droit à un **niveau de vie suffisan**t pour assurer sa santé, bien-être et ceux de sa famille, pour les soins **médicaux** et les services sociaux nécessaires (Art. 25)
1970	**Loi n ° 70-1318 portant réforme hospitalière**	• **1970 Loi 70-1318 de la réforme hospitalière** : ○ Affirme le droit du malade au **libre choix** de son **praticien** et de son **établissement** de soin ○ Loi fondamentale dans l'organisation des hôpitaux et la création des CHU (Centres Hospitaliers Universitaires)

II. Les droits fondamentaux des personnes : Emergence des droits des patients	**L'évolution historique des droits des patients 2/2**
1978	• **1978 : Loi°78-17** relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « **Informatique et libertés** » ○ Révisions 2004, 2017/2019 ▪ Cette loi a été révisée au regard des évolutions technologiques ○ Assure la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données nominatives ~~- Problématique de fuite des données qui peuvent mener à des ventes abusives et des arnaques~~
1988	• **1988 : Loi Huriet n° 88-1138** sur la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales : • Première loi sur l'expérimentation sur des humains
1990	• **1990 : Loi°90-527** : relative aux personnes hospitalisées pour des **troubles mentaux** ○ Droits des patients en milieu psychiatrique ○ Les personnes ne peuvent consentir du fait de leurs pathologies ▪ L'absence de consentement fait que ces pratiques sont très encadrées ○ Dérogatoire
1994 : Trois lois de bioéthique	• **Première loi bioéthique** : ○ Relative au traitement des données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé
	• **Seconde loi bioéthique :** ○ Relative au **respect** du corps humain : ▪ **Inviolabilité** du corps humain ▪ Impossibilité pour le corps humain d'être l'objet d'un **droit patrimonial évaluable en argent** ▪ Obligation du consentement
	• **Troisième loi bioéthique** : relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps, à l'assistance médicale, à la procréation et au diagnostic prénatal ○ Consentement préalable ou présumé et révocable à tous moments ○ Gratuité, anonymat, respect des règles de sécurité sanitaire ○ Statut de l'embryon, don d'organes
4 mars 2002	• **Loi n°2002-303 du 4 mars 2002** relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, appelée loi de **démocratie sanitaire**, ou loi « **Kouchner** » (alors ministre de la santé) ○ Reprend des jurisprudences et est très volumineuse ○ Vise à une médecine plus humaine où le patient est au centre de la prise en charge ▪ Pour une relation médecin / patient équilibrée ▪ Et la fin du paternalisme médical ▪ Promeut le « Droit de savoir » : pour consentir de manière éclairée • Elle est centrale et désormais dans le code de Santé publique
2005	• **2005 : Loi Claeys « Léonetti »** relative aux **droits des patients en fin de vie**, complétée en 2016 ○ Loi encadrant des pratiques déjà existantes ▪ Sujet très compliqué à aborder, loi remarquable ○ De nouvelles lois sur la fin de vie pourraient être potentiellement votées en 2026 • Idem pour les soins palliatifs
2007	• **Loi n ° 2007-308 du 5 mars 2007** portant réforme de la **protection juridique des majeurs** • Pour les majeurs ayant besoin d'être sous tutelle
2009	• **2009 Loi HPST** : réforme de l'Hôpital relatives aux patients, à la santé et aux territoires • Relative à la **modernisation des établissements de santé**, l'accès de tous à des soins de qualité, la prévention et la santé publique, l'organisation territoriale du système de santé
2012	• **Loi Jardé n ° 2012-300 du 5 mars 2012** relative aux **recherches impliquant la personne humaine** • Pour protéger l'individu et favoriser la recherche par l'expérimentation humaine

II. Les droits fondamentaux des personnes : Le respect de la dignité	**Le respect à la dignité**
Articles de loi	• Respect de la dignité : **l'un des droits fondamentaux** des patients • Deux articles encadrent le **respect de la dignité** : ○ **Article 16 du code civil** ▪ Principes de valeur **constitutionnelle** : Au-dessus de toutes les autres lois ▪ « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie » ○ Principe rappelé dans l'**Article L1110-2 du code de la Santé publique** ▪ « La personne malade a droit au respect de sa dignité » ○ Également inséré dans la Charte de la personne hospitalisée (2006) ▪ Charte : Texte qui n'a pas de valeur contraignante = un engagement de bonne pratique
Dignité et respect dans les soins 🎯	• **Le respect de la dignité se traduit :** ○ Dans la relation **soignant-soigné** verbale et non-verbale ○ Dans la relation avec le patient, sa famille, sa personne de confiance, ses proches ○ Il implique le : ▪ Droit à **l'écoute** ▪ Droit à l'information ▪ Droit à la confidentialité, au respect de la vie privée ▪ Droit à **l'intimité** - Ex : pouvoir faire ses besoins dans l'intimité aux urgences ▪ Droit à la qualité de soins ▪ Droit au respect de la fin de vie

II. Les droits fondamentaux des personnes : Le respect de la confidentialité	**Secret professionnel : respect du droit à la confidentialité**	
Existait déjà au temps d'Hippocrate (460 -377 av.JC)	• Droit de confidentialité : **un autre droit fondamental du patient** ○ Existait déjà aux temps d'Hippocrate (antiquité) • **Serment d'Hippocrate** que l'on prête lorsqu'on devient médecin : ○ « Admis c'est-à-dire dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés, reçu à l'intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas corrompre les mœurs » ○ Si le patient ne se sent pas en confiance, il peut cacher au médecin certains antécédents ou pratiques à risques, voire refuser de se faire examiner	
Fondements	• Le respect de la confidentialité protège **l'intérêt des patients** : respect de leur vie privée, **garantie de non-divulgation** • Facilite la prise en charge médicale et augmente sa qualité : ○ En évitant la **dissimulation d'informations** de la part du patient ○ Ce dernier est également en confiance pour montrer son corps	
Contenu	**Incombe à tout professionnel du système de santé**	• On parle de **secret professionnel** parce qu'il n'est **pas uniquement médical** : il concerne toutes les personnes susceptibles d'entendre des informations sensibles ○ Pas seulement les médecins ni les soignants , toutes les personnes qui travaillent dans le système de santé ▪ Un brancardier à la même obligation de secret professionnel que le médecin ou l'infirmier • Couvre l'ensemble des informations à caractère personnel concernant un patient, venu à la connaissance d'un professionnel de santé ○ Que ces informations lui aient été **confiées, rapportées** ou qu'il les ait **comprises**
	Secret professionnel a un caractère général et absolu	• Secret professionnel est **général et absolu** : ○ Ne peut souffrir d'aucune exception, sauf celles encadrées par la loi ○ Le médecin ne peut pas divulguer des informations de santé même à la demande du patient ○ Le décès du patient ne délivre pas le professionnel du **secret professionnel**
Cadre réglementaire	• **Code pénal Article 226-13 :** Le cadre réglementaire permet la mise en place de **sanction** en cas d'une **violation** du secret professionnel ○ Pour toutes les professions soumises au secret (pas seulement les médecins) ○ Révélation d'information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire : ▪ Soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende • Aussi dans le code de Santé publique (Article L1110-4) : ○ Souligne que le respect du secret incombe à tous les professionnels intervenant dans le système de santé	
Cadre déontologique	• Code de **déontologie médicale – Art. R4127-4 du CSP :** ○ « Le secret professionnel, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi » ○ « Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, de ce qui lui a été confié et de ce qu'il a entendu, vue, compris » • **Code de déontologie des infirmiers (Art. L4312-5 du CSP)** ○ Ancien décret de compétences des infirmiers, 1993 • Code de l'action sociale et de la famille (Art. L311-3)	

II. Les droits fondamentaux des personnes : Le respect de la confidentialité	**Aménagement de secret professionnel**	
Le secret partagé (art. L1110-4 du CSP)	**Aménagement du secret professionnel dans l'intérêt du patient**	• **Article L1110-4 du code de Santé publique : aménagement du secret professionnel** = permet **le partage des informations** concernant un patient ○ Entre tous les professionnels de santé qui participent à la prise en charge d'un même malade = son **équipe soignante** ○ Les informations ne sont transmises que quand elles sont **pertinentes** ▪ ~~Ex : un cardiologue a besoin de savoir que son patient a le sida, mais pas son assistante sociale~~ ▪ Ex. : Avertir l'infirmière sur l'allergie du patient à la pénicilline ○ A condition que ces informations soient strictement nécessaires ▪ A la coordination ou à la continuité des soins ▪ A la prévention ▪ A son suivi médico-social ▪ A la meilleure prise en charge sanitaire possible • **Permet la circulation** des informations et la **continuité** des soins et meilleure prise en charge • **Pour tout patient hospitalisé**, les informations confiées à un membre de l'équipe sont réputées transmises à l'ensemble de l'équipe : ○ Lors des réunions de staff, les informations transmises aux infirmiers et au médecins peuvent être mises en commun
Principales dérogations obligatoires	**Liés à l'état civil**	• Liées à **l'Etat civil** : ○ Établissement des certificats de **naissance et de décès** ▪ On transmettra l'heure, la date, le lieu, etc… mais pas la cause de décès
	Dites de santé publique	• Pour la **santé publique :** ○ On inscrit la cause du décès mais le patient est anonymisé ○ Utile pour les statistiques
	Certificats d'hospitalisation pour troubles mentaux	• Dans le cas **d'hospitalisation de personnes aux troubles mentaux** : ○ Besoins de certificats qui seront communiquée aux préfets, directeur d'établissement…
	Certificats médicaux dans le cadre de la protection sociale, protection sanitaire	• Dans **l'établissement de certificats médicaux** : ○ Certificats de vaccination, d'accident de travail ○ Déclarations de grossesse • Certificats d'hospitalisation sans consentement pour troubles mentaux
	Au bénéfice de la justice	• Dans le cas de **coups et blessures**, besoins de certificat médicaux pour la **justice** ○ Certificats sur réquisitions judiciaires : Description de blessure ○ Expertises médicales : contiennent seulement ce qui est **pertinent** sur les dommages corporels du patient
Dérogations possibles à la discrétion du médecin	• Dérogations possibles à la **discrétion** du professionnel de santé (discrétion = il décide) ○ Révélation d'un diagnostic ou d'un **pronostic grave** à la famille avant de le dire au patient, dans son intérêt ○ Communication du dossier médical possible aux ayants-droits/conjoint/proche d'un patient décédé ▪ Sauf si le patient s'y est opposé de son vivant ○ Article 226-14 du Code pénal : dans le cas de **signalements** de violences sur personnes vulnérables (enfants, personnes âgées, sous tutelle) ▪ Pour prévenir les autorités administratives, médicales ou judiciaires ▪ Aussi pour les violences conjugales	

II. Les droits fondamentaux des personnes	**Différents types de droits à la *protection de la santé***
Le droit à la protection de la santé	• Depuis le 4 mars 2002 : tout le monde a droit à la **protection de la santé** ○ **Art. L1110-1** du code de Santé publique ○ L'Etat doit **tout mettre en œuvre** pour permettre aux individus de rester en bonne santé ▪ « Par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne »
	Droit garantis • Droit à la **prévention** • Droit **d'égal accès** à des **soins de qualité adaptés** • Droit à la **sécurité sanitaire** • Droit à la prise en charge de la douleur et droit aux **soins palliatifs**
Droit à la prévention	• L'accès à la prévention et aux soins des **populations fragilisées** constituent un **objectif prioritaire** de la politique de santé ○ Fragilisée = pour des raisons sociales et de santé ▪ Ex : familles pauvres, mais aussi individu en insuffisance cardiaque • Article L1411-1 en **2004** du code de Santé publique, loi relative à la politique de santé publique ○ Mises en place de politiques de **prévention** pour « **la santé tout au long de la vie** » ○ Actions prioritaires : ▪ Informer pendant la grossesse, vacciner dans la petite enfance ▪ Promouvoir l'activité physique chez les enfants pour lutter contre l'obésité ▪ Lutter contre les cancers et les consommations à risque, Ex. : Protoxyde d'azote, tabac et alcool ▪ Lutte contre les violences intra-familiales ▪ Contrôler la qualité de l'air et l'impact de l'environnement sur la santé ▪ Prévention de la perte d'autonomie, soins buccodentaires dans les EHPADs, ect. ▪ Qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique ▪ Lutte contre les maladies rares
Droit d'égal accès à des soins de qualité	• Droit d'égal accès au soin de qualité : ○ **Libre choix** de son praticien et de son établissement de santé ○ Soin **conformes** à l'état de santé, degré **d'urgence** et aux données acquises de la **science** ▪ Pas de **charlatanisme** ou de soins **expérimentaux**. ~~Ex de l'hydroxychloroquine pendant le covid~~ ▪ Si soins expérimentaux : il faut respecter les règles de la recherche médicale ○ **Non-discrimination** des usagers du parcours de soin (selon l'âge, la couleur…) ▪ L'élément déterminant de l'accès au soin c'est la pathologie
Droit de prise en charge de la douleur	• **1995 et 2005** Droit de prise en charge de la **douleur :** ○ Obligation légale et déontologique, participe au respect de la dignité • **1999 Soins palliatifs** dans le code de Santé publique = **soins actifs et continus** visant à **soulager la douleur, la souffrance physique,** sauvegarder **la dignité** de la personne malade, et **soutenir son entourage** ○ Les soins « palliatifs » (pour pallier) s'opposent aux soins curatifs (pour soigner) ○ Aussi pour le bien-être psychologique • Développement **d'unités de soins palliatifs** dans le service public et établissements privés hospitaliers ○ Participation au service public en tant que structures de soins alternatives à l'hospitalisation ○ Problème du manque de lits en soins palliatifs ○ Doivent être réformer en 2025 en même temps que la loi sur la fin de vie
Droit à la sécurité sanitaire	• Droit à la sécurité sanitaire : ○ « Contre les risques thérapeutiques de toute nature, risques liés aux choix thérapeutiques, aux actes de prévention, de diagnostics ou de soins, à l'usage des biens et produits de santé comme aux interventions et décisions des autorités sanitaires » (Tabuteau) ▪ Tout ce qui peut **mettre en danger** la santé des personnes lorsqu'elles bénéficient de soins dans le système de santé • Ex. : Contrôle des produits, gestion des laits contaminés, retrait de lots • Ex d'une radiothérapie trop dosée : il faut prévenir toutes les personnes qui l'ont faite ○ Les **bénéfices** attendus par le patient doivent être **supérieurs** ou au moins égaux aux **risques** encourus ▪ En discuter avec le patient et sa famille • Agences sanitaires évaluent la sécurité sanitaire : ○ Comme Santé Publique France, la Haute Autorité de Santé, Agence National Sécurité Médicament…

II. Les droits fondamentaux des personnes	**Différents droits des patients en fin de vie lors des soins**
Les lois pour la fin de vie	• Le droit à la fin de vie vise à **soulager la douleur** des patients • **Deux lois** : ○ **Loi Léonetti** du 22 avril **2005 :** Droits des malades et à la fin de vie ○ Loi Claeys-Léonetti de 2 février **2016** : Nouveaux droits pour les malades et personnes en fin de vie
Droit de soulager la douleur	• Le droit à la fin de vie permet **l'utilisation de médicaments** pour soulager la douleur même s'ils peuvent **abréger l'existence** ○ Exemple, la **morphine** est un antalgique très puissant mais elle peut **entrainer des atteintes respiratoires centrales** ○ Dans le code de Santé publique : ▪ L'usage de ces médicaments est seulement pour les malades **incurables**, que l'on ne peut soulager autrement ▪ Il est **très encadré** : il faut **informer** le malade et les proches, en discuter en équipe de service et la procédure est inscrite dans **le dossier médical**
Droit au refus de l'acharnement thérapeutique	• Une personne peut **refuser des soins** : droit au **refus de l'acharnement thérapeutique** (Code de santé publique) : ○ Personne en phase avancée ou terminale d'une affection grave et **incurable** peut demander l'arrêt du traitement, **après** avoir été informée par le médecin des **conséquences** ○ Le médecin **doit** respecter sa volonté ○ La décision du malade doit être inscrite dans son dossier médical ○ Le médecin sauvegarde la dignité du mourant en lui dispensant des soins palliatifs ○ La procédure est **collégiale** : fait appel à des professionnels extérieurs au service, en concertation avec la famille • Limitations ou **arrêt** des **thérapeutiques** actives : ○ Procédure collégiale, en concertation avec la famille • Refus de l'acharnement thérapeutique : promeut l'absence **d'obstination déraisonnable** ○ Par la suspension d'actes de prévention ou de soins inutiles, disproportionnés ou n'ayant d'autres effets que le maintien artificiel de la vie ○ Cela **ne signifie pas arrêt des soins** – en particulier des soins palliatifs
Droits de rédiger des directives anticipées	• **Les directives anticipées : instructions écrites, datées et signées**, notifiées par le patient pour les cas où il serait incapable d'exprimer sa volonté ○ Notamment par rapport à sa **fin de vie** ▪ Ex. : Refus de trachéotomie ○ Lorsque le malade n'est plus en état de répondre en question, les médecins pourront consulter ses instructions rédigées ○ Doivent être **respectées par le médecin** sauf en cas **d'urgence** ○ Poursuite, limitation, arrêt ou refus de traitement ou d'acte médicaux ○ **Révisables** et **révocables** à tous moments : ○ Dans le cas où le patient a écrit ses instructions lorsque son état était grave par exemple, et qu'il désirait à présent les modifier

III. Les droits des usagers du système de santé	**Droit d'information du patient**

Art. L1111-2 CSP : « Toute personne a droit d'être informée sur son état de santé… »	• Déjà présent dans la jurisprudence, entre dans le code de Santé publique
	• **Article L1111-2 du code de Santé publique** : tout personne a droit d'être **informée** sur son état de santé
	• **L'information** peut être délivrée par **2 professionnels pour reformulation**
	• Participation du patient à la prise de décision concernant sa santé :
	  ○ Permet un **consentement éclairé**
	  ○ Incombe à tout professionnel de santé
	  ○ L'information doit contenir :
	  ▪ Etat de santé du patient : maladies, diagnostic, facteurs de risque, pronostic
	  ▪ Les examens complémentaires et traitements proposés
	  ▪ Tous les risques de la maladie et des traitements
	  ○ Selon code de déontologie médicale : l'information doit être **loyale**, **claire** et **appropriée**
	  ▪ Il faut vérifier que l'information est bien comprise
	  ▪ Adaptée au degré de **maturité** du malade et ses facultés de **discernement**
	• L'accès à l'information permet de **recueillir le consentement**

III. Les droits des usagers du système de santé	**Consentement au soin**

Consentir : « Accepter qu'une chose se fasse »	• Le **consentement = « accepter qu'une chose se fasse »**
	• **Le consentement** du patient majeur, en état d'exprimer sa volonté, est **obligatoire** avant tout acte médical
	  ○ Le consentement doit être **éclairé** : le patient doit être bien informé des risques et des alternatives thérapeutiques
	  ○ Art. L1111-4 du CSP : le consentement peut être **retiré à tout moment**
	• Le recueil du consentement vise à ce qu'une personne soit **actrice de sa propre santé**
	  ○ La personne agit pour sa santé avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et préconisations qu'il lui fournit
	  ▪ Ex : on peut refuser une chimio ou une dialyse après deux ans de traitement
	  ○ Le patient doit être **respecté** par le professionnel. Ce dernier doit :
	  ▪ Accepter le refus, informer le patient des conséquences du refus, et le notifier dans le dossier médical
	  ▪ Eventuellement proposer un second avis médical au patient
	  ▪ Donner les meilleurs soins malgré le refus

III. Les droits des usagers du système de santé	**Droit de désigner une personne de confiance**

La personne de confiance : (Art. L1111-6 CSP)	• **Article L1111-6** du Code de Santé publique : on peut désigner **une personne de confiance**
	  ○ Accompagne et soutien le patient dans son parcours de soins
	  ○ Assiste aux entretiens médicaux
	  ○ Aide le patient à prendre ses **décisions médicales**
	  ○ Informée et consultée avant tout acte ou prise en charge quand le malade ne peut exprimer sa volonté ou en cas de décision de limitation ou d'arrêt des thérapeutiques
	  ▪ Ne prend **pas de décision médicale** à la place du malade
	  ▪ C'est l'équipe soignante qui la prend si le malade ne peut consentir
	  ○ **Qui** ? Un parent, un proche, le médecin traitant
	  ○ **Comment** ? Par écrit, révocable à tout moment, document **cosigné** par la personne désignée
	  ▪ Le nom de la personne de confiance doit être communiqué lors de toute hospitalisation et doit figurer dans le **dossier médical**

III. Les droits des usagers du système de santé	**Accès dossier médical**

Dossier médical	• Décret du 29 avril 2002 : le droit d'accès au dossier médical du patient
	  ○ Dans le **prolongement** du droit à **l'information**
	  ○ **Avant** on ne pouvait y accéder que par **l'intermédiaire d'un médecin**
	  ▪ Ancienne volonté du corps médical de cacher des choses
	• Le dossier médical contient :
	  ○ Des **informations communicables** :
	  ▪ Les informations formalisées lors des consultations externes, des consultations aux urgences, de l'admission, tout au long du séjour hospitalier et à la fin du séjour
	  ▪ Seulement celles à **caractère médical**
	  ○ Des **informations non communicables** :
	  ▪ Notamment les informations recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge ou concernant des tiers - comme les informations transmises par ou sur la famille
	• **Article L1111-7** du Code de Santé publique :
	  ○ Toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé
	  ○ Possibilité d'accéder **directement** à son dossier, ou par **l'intermédiaire** du médecin de son choix
	  ▪ Le médecin peut **recommander** de passer par une tierce personne en cas d'informations choquantes nécessitant un accompagnement, mais le patient a le dernier mot
	• Loi ambitieuse de la part du législateur

Réglementation spécifique	• En psychiatrie, **hospitalisation sans consentement :**
	  ○ En cas de risques d'une gravité importante, la consultation du dossier se fait **avec un médecin tiers**, désigné par le patient
	• **Délai : 48 h de réflexion pour le demandeur lors de la demande du dossier**
	  ○ La transmission doit s'effectuer dans les **8 jours** / 2 mois (dossier > 5 ans)
	  ○ Très contraignant pour les établissements et les professionnels

III. Les droits des usagers du système de santé	**La charte de la personne hospitalisée**	

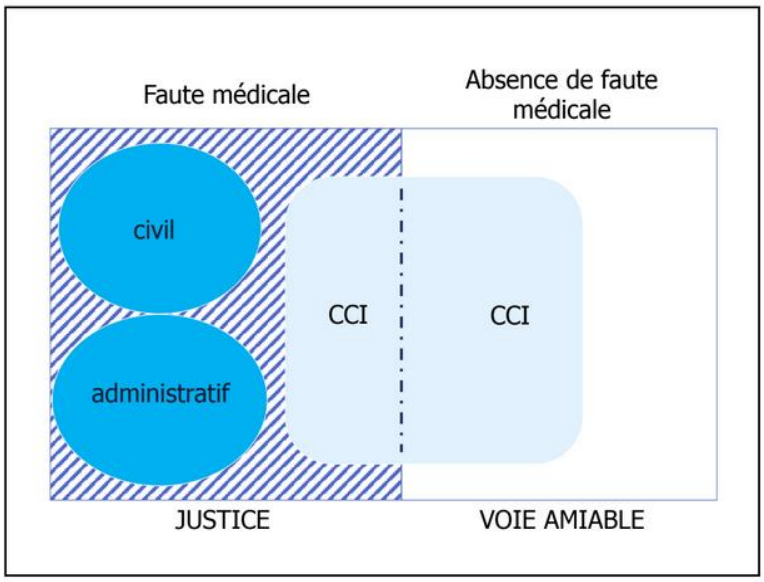
11 Droits fondamentaux	• En **2006** : Charte de la personne hospitalisée
	  ○ **Diffusion large** par des affichages et livrets d'accueil remis au patient lors de l'hospitalisation
	  ○ N'a **pas de force contraignante en soi** mais les droits des patients y sont inscrits et sont des obligations légales
	  ○ Témoigne de l'engagement de l'établissement au **respect de ces droits fondamentaux**	

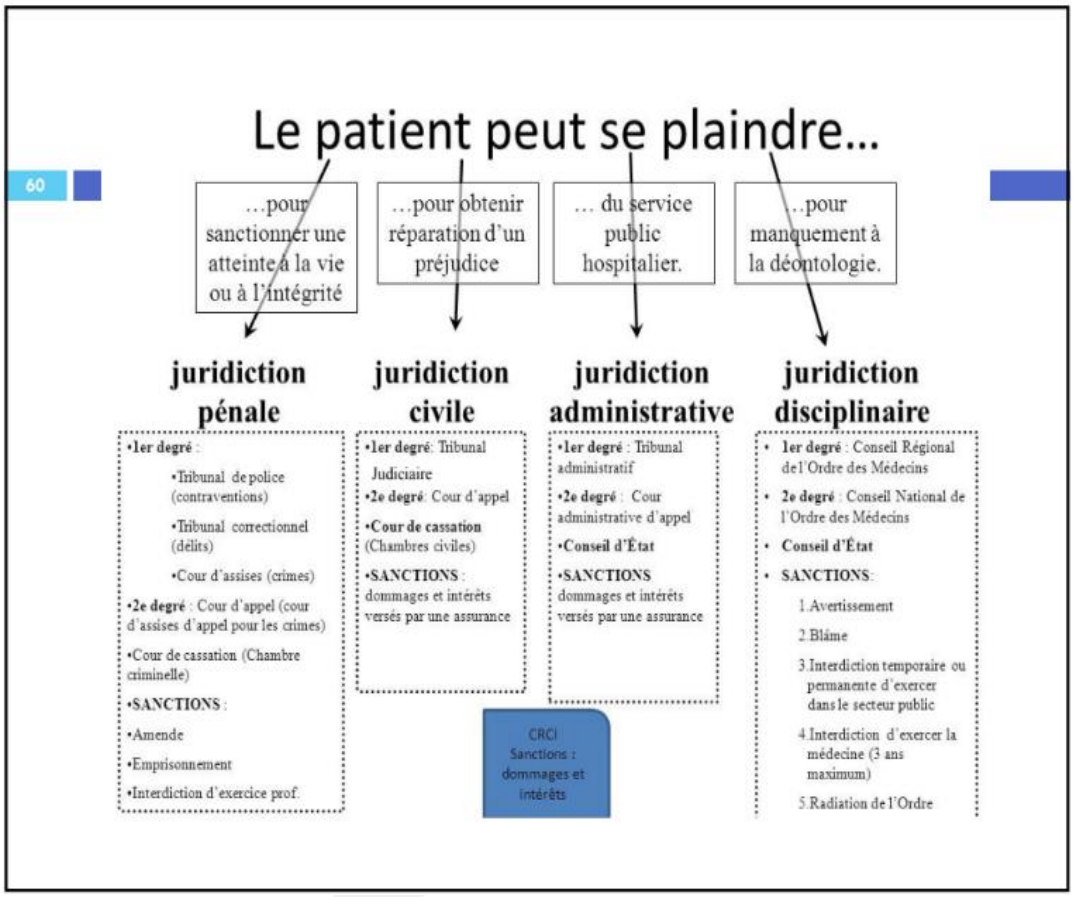
	1	• Libre choix de la personne
	2	• Droit au refus de soins
	3	• Qualité de l'accueil, des traitements et des soins
	4	• Information de la personne, sa participation à sa prise en charge
	5	• Droit à désigner une personne de confiance
	6	• Consentement aux soins
	7	• Droit de rédiger des directives anticipées
	8	• Respect des croyances
	9	• Respect de l'intimité, de la vie privée, de la confidentialité
	10	• Accès aux informations le concernant (dossier médical)
	11	• Existence d'une Commission de relations avec les usagers

IV. Responsabilité des professionnels de santé	**Introduction**
Notion de responsabilité	• La responsabilité des professionnels de santé est un peu **particulière** parce qu'ils sont toujours en contact avec d'autres humains ○ Ils doivent **répondre de leurs actes** = expliquer les motivations de ses actions ▪ Devant la société et devant un individu ▪ **Réparer les dommages** dans le cas où les actes ont entrainé des conséquences • Chaque professionnel est **soumis au droit commun** ○ Et doit répondre de ses actes ou de ses omissions **devant la justice** ▪ Du fait de ses **obligations** ou de son **exercice** professionnel • La responsabilité peut être mise en jeu de **deux** façons : ○ La « **responsabilité sanction** » ▪ Entraîne la **responsabilité pénale** : Sanction de la **société** pour quelqu'un qui a mal agit ▪ Et/ou la **responsabilité disciplinaire** : Sanction de **l'ordre professionnel** - Comme l'ordre des médecins ○ La « **responsabilité indemnisation** » ▪ Entraine la responsabilité **civile** ou **administrative** : **réparation financière** d'un dommage causé à une victime - Civil : pour un médecin libéral - Administrative : pour un médecin dans un établissement
Références opposables	• Les textes **opposables** (= recevables lors d'un procès à charge) aux professionnels de santé : ○ Textes de droit commun ▪ Code pénal, code civil, code de santé publique ○ Codes de Déontologie

IV. Responsabilité des professionnels de santé	**Responsabilité pénale**
L'infraction pénale	• **L'infraction pénale** : réalisation d'une faute **personnelle** allant à l'encontre de la loi ○ La responsabilité est individuelle ▪ Ex : faire un faux certificat, violer le secret professionnel ○ C'est une **atteinte à l'ordre public** car cela **enfreint à la sécurité** des biens et des personnes ○ Entraîne une sanction • Le professionnel de santé peut être poursuivi pénalement, comme tout citoyen et quel que soit son mode d'exercice
Juridictions	• Les procès au pénal se font dans : ○ Le tribunal de police (pour les contraventions), le tribunal correctionnel (pour les délits), ou la Cour d'Assises (pour les crimes) ▪ Les procès en Cour D'Assises ou tribunal de police sont rares, c'est plutôt le **tribunal correctionnel** qui s'occupe du domaine médical ▪ Cela dépend de la gravité de la faute
Sanctions	• Peines : **amende, prison** ferme ou avec sursis • Peines complémentaires : Ex : interdiction d'exercice

IV. Responsabilité des professionnels de santé	**Responsabilité disciplinaire**
Peut être engagée	• La responsabilité disciplinaire est engagée dans les **professions disposant d'un ordre professionnel** ○ En cas de violation ou de non-respect d'une règle professionnelle ou de dépassement de ses compétences (Ex : infirmières qui font un acte de médecin) ▪ Ordres professionnels des médecins, dentistes, sage-femmes, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, podologue-pédicures ○ L'employeur peut faire des sanctions disciplinaires, en cas de désobéissance du règlement intérieur

IV. Responsabilité des professionnels de santé	**Responsabilité indemnitaire**
Définition	• La responsabilité **indemnitaire** est : ○ Une responsabilité **civile** pour un professionnel libéral ○ Une responsabilité **administrative** pour un professionnel dans un établissement public de santé • Le but = réparer un préjudice causé à autrui de son propre fait par **indemnisation financière** ○ « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » **art. 1382 Code civil**
L'apport de la loi du 4 mars 2002	• La **loi du 4 mars 2002** de démocratie sanitaire : modifie le système de responsabilité médicale en **harmonisant** les systèmes de **responsabilité privé et public** • S'il y a besoin **d'indemniser un patient**, plusieurs possibilités : ○ S'il y a **faute** des soignants, le patient peut porter plainte et réaliser une **procédure judiciaire** ▪ Art. L1142-1 du Code de Santé publique La responsabilité médicale ne peut être engagée **qu'en cas de faute** ▪ Le délai de prescription dans le médical est de 10 ans ○ OU le patient peut demander un **accord à l'amiable** en recourant à la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) ▪ **Sans faute**, la CCI permet d'indemniser **l'aléa thérapeutique** - Dans ce cas c'est la **solidarité nationale** qui indemnise le patient ▪ **Avec faute ou** affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales : Indemnisation à l'amiable - Art L1142-4 du Code de Santé publique - A l'amiable = sans procédure judiciaire, plus rapide - C'est **l'assureur** de l'établissement ou du médecin qui indemnise le patient
Schéma	

IV. Responsabilité des professionnels de santé	**Responsabilité civile ou administrative**
Responsabilité civile	• **La responsabilité civile incombe aux professionnels de santé dans le privé :** ○ Activité libérale, en cabinet, clinique… ○ Il s'agit d'une **responsabilité personnelle** ○ Le soignant doit avoir une **assurance civile professionnelle**
Responsabilité administrative	• **La responsabilité administrative** incombe aux **établissements publics et collectivité territoriale :** ○ Et aux professionnels **travaillant en secteur public** ○ **Sauf exceptions :** relève alors de la responsabilité civile 
Procédure amiable	• En **cas de faute** : accident médical • En **l'absence de faute** : aléa thérapeutique ○ Au titre de la solidarité nationale ▪ Ex. : Vaccination, missions de service public

IV. Responsabilité des professionnels de santé	**Conclusion**
A retenir	• Évolution législative permanente • Suit l'évolution des mentalités et des pratiques • Fait naître des questions éthiques • Droits des patients et obligations pour les professionnels de santé ○ Pour une meilleure prise en charge des patients, plus humaine ○ Respect mutuel